

Éducation thérapeutique du patient

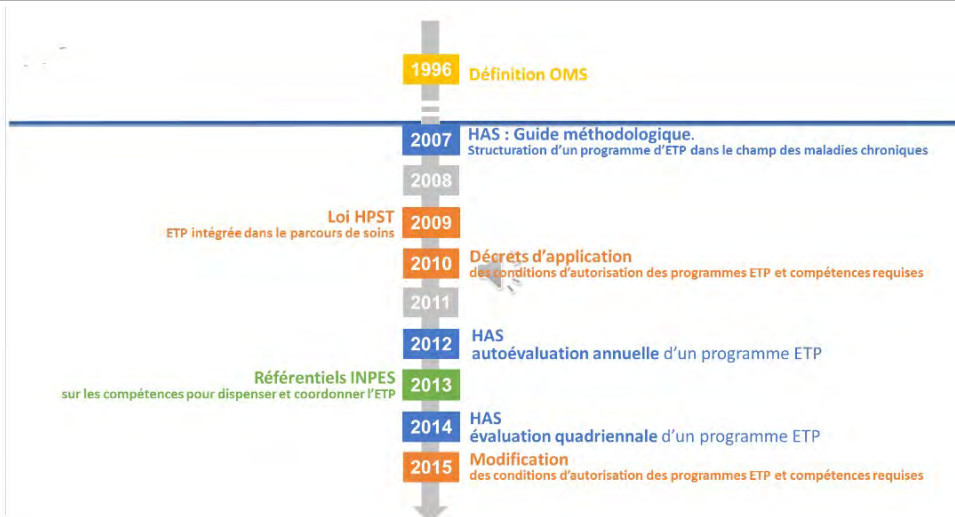
Contexte, définition et cadre de mise en œuvre

1. Contexte du développement de l'ETP

Hausse de la prévalence des maladies chroniques	→ développement de l'ETP en lien avec l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques ++ → phénomène lié à l'amélioration des conditions de vie de la population et au progrès de la médecine qui ont entraîné un vieillissement de la population <u>Rapport 2017 sur l'état de santé de la population en France (DREES et Santé Publique France) :</u> -37% de la population concernée par une maladie chronique ou un problème de santé durable -15 à 20 millions de personnes en France
Poids important des maladies chroniques sur les dépenses de santé	<u>A cause des maladies chroniques :</u> -altération des conditions/confort de vie -possible complications graves -représente une cause importante de handicap et de décès <u>Données assurance maladie 2017 :</u> • 17 % des affiliés en ALD (diabète; insulinsécoronarienne, HTA sévère, cancers, etc.) • 65% des dépenses de santé. → L'ETP : une voie pour favoriser l'implication des personnes malades dans leurs soins et améliorer l'état de santé des populations (OMS 2003)

Déploiement de l'ETP en France :

-Terme de l'ETP apparu dans les années 1970
-Il a fallu attendre 1996 pour que les contours soient précisés
-Définition reprise en 2007 avec développement de guide de bonnes pratiques
-Avant 2009 ETP déjà présente dans les pratiques de soins mais pratiques assez hétérogènes dans leur contenu et leur mise en œuvre par manque de cadre clair
-**2009** a marqué une étape importante avec la loi HPST → ETP inscrite dans le code de santé publique comme une approche devant être intégrée dans le parcours de soins chroniques
-Peut à présent développement de programme structuré répondant à un cahier des charges nationales



→ Les professionnels qui dispensent cette ETP au sein des programmes autorisés par ARS, doivent justifier d'une formation spécifique de 40h minimum → publication par INPES en 2013 des compétences nécessaires pour dispenser et coordonner l'ETP

2. Définition – cadre conceptuel

Définition de l'OMS en 1996 reprise par la HAS 2007	"L'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient (= stratégie thérapeutique) Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie."
--	--

Une approche intégrée à la promotion de la santé	<u>3 principes essentiels</u> (issue de la Charte d'Oswawa et Jakarta) • éducabilité de tous les patients. (=chacun est capable d'apprendre) • prise en compte de l'ensemble des éléments qui affectent la santé de la personne. (= approche centrée sur la personne) • respect de la personne et de sa liberté de choix.
ETP = une approche à la croisée de plusieurs disciplines	• Les sciences médicales (= touche la maladie et les TTT) • Les sciences humaines et sociales : psychologie de la santé, sociologie, anthropologie. (=accompagnement) • La pédagogie (=apprentissage et développement de compétences) → influence ± importante sur la modélisation des pratiques même si le cadre réglementaire est bien posé → hétérogénéité dans les pratiques

4 points repères pour définir le cadre de l'ETP :

• Processus d'accompagnement et d'**apprentissage intégré à la stratégie thérapeutique tout au long du parcours de soins** qui vise **l'empowerment**. (= retrouver le sentiment de contrôle sur la maladie et la vie en générale)
→ ETP ne se résume pas uniquement aux pratiques mis en œuvre mais aussi à une **posture**

• Approche **centrée sur la personne et son entourage** : prise en compte de la réalité du patient dans son expérience avec la maladie.

→ mise en accord constante entre la personne et l'équipe de soin

« Il ne s'agit pas d'inculquer au patient de nouvelles compétences, ni de le rééduquer en fonction de normes arbitraires, mais de l'aider, par le biais de la relation, à retrouver ses capacités et à s'équilibrer dans le cadre de sa personnalité afin de l'aider à faire face à sa maladie. » (Laurent Morasz- 2002) / mise en accord constante avec la personne malade.

• Approche **pluriprofessionnelle et transdisciplinaire**.

• **Démarche structurée** (critères de qualité admis au niveau international)

3. Cadre réglementaire de mise en œuvre

Loi HPST 2009 : Programme structuré d'ETP	• Ensemble coordonné d'activités d'éducation animées par une équipe de professionnels de santé et de patients formés. • Destinées aux patients et leur entourage • Cadre de référence pour la mise en œuvre des programmes personnalisés. • Vise le développement des compétences d'auto-soins et de compétences d'adaptation. Spécifique d'une maladie spécifique ou d'une situation de polyopathologies. Mis en œuvre dans un contexte donné et pour une période donnée, par des intervenants qui ont suivi une formation en ETP (40h minimum). Répond à un cahier des charges - autorisation de l'ARS pour 4 ans. <u>Informations à décrire dans le dossier ARS de demande d'autorisation :</u> • La structure qui porte le programme → <i>Un programme ETP peut être hébergé par différents types de structures : établissement de santé, maison ou pôle de santé, réseau de santé, association</i> • L'équipe et le niveau de formation • Le programme • La coordination • L'éthique, la confidentialité et la déontologie • L'évaluation • Les modalités de financement
Programme d'ETP : l'équipe (professionnels et patients ressources)	• Affectation de formation de chacun individu → <i>pour la demande d'autorisation auprès de l'ARS avec le volume horaire et les objectifs de la formation</i> • Préciser le rôle de chacun. • Coordination : par un médecin ou un autre professionnel de santé ou par un représentant d'association de patients → <i>les individus autres que des professionnels de santé (ex : psychologue) ne sont en théorie pas autorisés à coordonner un programme</i> → pour les coordonnateurs : Affectation de formation 40h + compétences spécifiques de coordination

Descrip on du programme d'ETP	• Situa on(s) clinique(s) couverte(s). • Public (pa ents, proches, précarité, territoire ,critères d'inclusion). • Modalités d'élabora on du programme, notamment implica on des professionnels et pa ents concernés et les données d'e cacité disponibles. • Objec fs du programme (compétences), critères de jugement de son e cacité (bio-psycho-sociaux). <u>Étapes de mise en œuvre de la démarche éduca ve :</u> • Diagnos c éduca f, co-défi i on du projet éduca f individualisé, évalua on. • Modalités de synthèse et transmission des informa ons. • Existence et format du dossier d'éduca on thérapau que. • Descrip on des ac vités proposées (type de séances, objec fs et déroulement, ou ls et techniques pédagogiques, etc.)
	<u>Dossier suite :</u> -Procédures de coordina on dans l'équipe (bénéfi iaires et pra ques). (→ partage d'informa on au sein de l'équipe) -Procédures de coordina on avec les autres intervenants du parcours de soins (ex : médecin traitant) -Recueil du consentement et modalités d'informa on du pa ent. (→ par cularités et spécifi ités possible en fonc on de l'ARS) -Charte d'engagement de con den alité et de déontologie pour les intervenants. -Descrip on de ce qui est prévu pour l'organisa on prévisionnelle de l'auto-évalua on annuelle et de l'évalua on quadriennale du programme. -Transmission annuelle des données d'ac vité de l'année N-1 à l'ARS. Tout les 4 ans rédac on d'un rapport synthé que d'évalua on quadriennale : • évolu ons du programme sur les 4 années. • e ets du programme sur les bénéficiaires, l'équipe et l'intégra on dans l'o re de soins. Autorisa on obligatoire mais ne vaut pas accord de nancement. Dépôt du dossier : pli recommandé avec demande d'avis de récep on dans la DT (= délégation territoriale) de l'ARS. Délais d'instruc on : • 1 mois pour statuer sur le caractère complet du dossier. • 2 mois à compter de l'a esta on de complétude du dossier pour instruire le dossier. → ARS donne son accord sous 2 mois
Condi ons d'autorisa on	• Validité 4 ans puis demande de renouvellement avec remise de l'auto-évalua on quadriennale (e ets et évolu ons du programme) • Certaines modi ca ons apportées au programme sont soumises à autorisa on préalable de l'ARS: changement de coordonnateur, d'objec fs ou de source de nancement. → Caducité du programme s'il est non mis en œuvre dans les 12 mois qui suivent son autorisa on ou pendant 6 mois consécu fs.
RÉSUMER : Étapes d'élabora on d'un programme d'ETP	• Cons tuer et former l'équipe ETP professionnelle comprenant des usagers. • Recueillir et analyser les données disponibles : recommanda ons professionnelles, li érature scien fi ue per nente dans le domaine des sciences médicales, sciences de l'éduca on, psychologie de la santé, sciences humaines et sociales. • S'accorder dans l'équipe sur les fondements théoriques du programme d'ETP. • Dé nir ensemble les objec fs, le contenu du programme, ses modalités de mise en œuvre, de coordina on et d'évalua on

Chap 2 : Le diagnostic éducatif (ou Bilan Educatif Partagé)

DE = Diagnostic Educatif

BEP = Bilan Educatif Partagé

I- Le diagnostic éducatif (ou BEP)		
Définition	Pour la HAS : BEP = 1^{ère} étape de la démarche éducative Etape importante, qui sert plusieurs objectifs ✚ Faire connaissance (avec le patient et son entourage) et initier une relation de confiance ✚ Expliquer ses intentions et la démarche proposée ✚ Analyser avec le patient (+/- son entourage) sa situation ✚ Identifier les besoins éducatifs et les ressources (parfois ressources = compétences) ✚ Convenir ensemble du projet éducatif individualisé	
Principales différences avec le diagnostic médical	/!\ DE fait trop référence au diagnostic médical → BEP est plus utilisé → 2 approches très différentes	
	Diagnostic médical	Diagnostic éducatif
	L'objet	Maladie
	L'approche	Recherche de dysfonctionnements Recueil de données
	Qui conduit la démarche (+positionnement)	Patient +/- entourage dans son environnement → Dimensions sociales, cognitives, comportementales, psychoémotionnelles
	Positionnement du patient	Identification et valorisation des ressources du patient Approche narrative Ecoute non sélective, accueil du vécu et des émotions
	Qui conduit la démarche (+positionnement)	Le médecin (Expertise)
	Positionnement du patient	Tout membre de l'équipe d'ETP (Sollicite et reconnaît le savoir de l'expérience de la personne)
	Finalités	Actif et impliqué dans l'analyse et les décisions Relation partenariale
II- Mise en œuvre du BEP		
→ Essayer d'accéder à la complexité de ce que vit chaque personne dans sa confrontation quotidienne avec sa maladie chronique ○ Repose sur un entretien de compréhension semi-dirigé, centré sur la personne ⇒ parfois entretien aussi avec l'entourage (avec le consentement du malade) ○ Mise en place de conditions favorables à une relation de confiance : ✚ Lieu accueillant ✚ Disponibilité de la personne malade et de la personne qui mène l'entretien → prévoir environ 45min à 1h ✚ Confidentialité ✚ Consentement de la personne pour la transmission des informations recueillies → respecter une potentielle demande de garder certaines infos confidentielles ○ Mettre en place une écoute active et non sélective de la personne ✚ Recours aux techniques d'entretien qui favorisent l'expression ✚ Être attentif à ses propres attitudes en tant qu'écouter <u>Autres modalités à envisager</u> en fonction de la nature de la maladie chronique, de l'âge du patient, de sa situation personnelle... ⇒ Par ex, en pédiatrie : temps d'entretien avec l'enfant malade, temps séparé avec uniquement les parents puis temps partagé avec les parents et le patient		
3 attitudes clés (Carl Rogers)	→ Mise en place d'une approche centrée sur la personne (Carl Rogers) Point clé de cette approche = croire que « Chaque individu a en lui des capacités considérables de se comprendre, de changer l'idée qu'il a de lui-même, ses attitudes et la manière de se conduire ; il peut puiser dans ses ressources, pourvu que lui soit assuré un climat fait d'attitudes facilitatrices »	

Attitudes facilitatrices	✚ Empathie : capacité à entrer dans le monde de l'autre comme s'il s'agissait du sien propre afin de le comprendre → écouter l'autre de façon très attentive (contenu ET non-dit/non-verbal) → développe une proximité à l'autre, sans s'identifier à lui ✚ Congruence : cohérence entre la conscience de soi et ce qui est exprimé → être en contact avec ce qu'on écoute et ce qu'on ressent en tant qu'aidant (et l'exprimer verbalement si le moment est opportun) ✚ Acceptation inconditionnelle de la personne : porter un regard sur autrui respectueux et sans jugement, fondé sur la confiance dans son autoréalisation → nécessite d'être conscient en tant qu'écouter de ses représentations positives ou négatives vis-à-vis de cette personne afin de les reconnaître en toute lucidité
Les attitudes spontanées freins à l'écoute active (Elias Porter)	Frein à une écoute active, authentique et respectueuse de la personne → important de les connaître pour les éviter ✚ Le jugement (positif ou négatif) : risque de mettre l'autre dans une position de soumission et dévaloriser son estime → « c'est bien », « à mon avis », etc... ✚ L'interprétation : selon ses propres croyances et valeurs peut mener à un sentiment d'incompréhension et de désintérêt de la part du patient → « si vous dites cela, c'est parce que... mais en réalité... » ✚ Le conseil, la dédramatisation : l'écouter se place en position de conseiller, cherche à protéger, rassurer, dédramatiser ; peut entraîner le sentiment d'être pris en pitié et de limiter son autonomie et son estime personnelle ✚ L'écoute autoritaire : décider ce que l'autre doit faire ; cela le pose dans une relation de domination et de soumission, ce qui n'est pas souhaitable lorsqu'on recherche une autonomie décisionnelle ✚ L'enquête : cherche à préciser des points d'intérêts uniquement de la personne qui les pose ; cela peut amener l'autre à devoir se justifier, à avoir le sentiment d'être pris au piège et à se sentir coupable.
Les attitudes d'entretien qui favorisent l'expression	Chaque situation de vie avec la maladie est unique → difficultés rencontrées, ressources mises en œuvre, aspirations et projets que la maladie vient bousculer → il faut favoriser l'expression de la personne malade ✚ Poser des questions ouvertes (on ne peut pas y répondre par oui ou par non) ○ Encourage la personne à s'exprimer, elle est libre de répondre comme elle l'entend ○ Contribuent à créer un climat de confiance ○ Favorisent l'élaboration, l'expression des ressentis ✚ Reformuler permet de : ○ Montrer qu'on écoute ○ Vérifier qu'on a compris ○ Inciter la personne à approfondir (relancer la réflexion, faciliter l'expression) ○ Amplifier, faire écho à certains propos de la personne, lui permettre d'entendre ce qu'elle dit ⇒ Reformuler les faits, émotions, opinions, valeurs, idées, besoins, attentes, demandes → « si j'ai bien compris », « vous pensez donc que », « selon vous », « vous voulez dire que »
Les clés de l'écoute active au service du BEP	Principaux conseils pour une écoute active et respectueuse ✚ Rester neutre et bienveillant ; exclure ses idées préconçues, éviter le jugement et l'interprétation ✚ Laisser la personne s'exprimer sans l'interrompre ✚ Respecter les moments de silence qui permettent à la personne d'approfondir sa pensée ✚ Adopter une attitude physique de disponibilité ; montrer des signes verbaux et non verbaux d'intérêt ✚ Poser des questions ouvertes ✚ Utiliser des relances pour clarifier, faire préciser les propos ✚ Reformuler

Entretien semi dirigé	⇒ Pas complètement libre mais pas fermé non plus Orienté sur des thématiques en partie prédéfinies, en lien avec les objectifs de la démarche éducative → concernent le quotidien avec la maladie chronique mais aussi les déterminants et les dimensions de la santé de la personne dans son environnement → thématiques adaptées à la nature de la pathologie, à l'âge de la personne et à sa situation particulière Aborde : - Les effets de la maladie et des ttt sur la vie quotidienne (perception de la personne) - Les ressources personnelles, sociales - Les relations émotionnelles, le ressenti, le vécu - Les connaissances, les croyances, les représentations (maladie, ttt, parcours de soins) - Les raisonnements, les valeurs - Les facteurs de vulnérabilité - Les demandes, priorités, projets exprimés										
Le guide d'entretien	Support utilisé par bcp d'équipes d'ETP Reprend les dimensions à explorer (+exemple de questions ouvertes) ⇒ permet d'ouvrir les échanges Présente des avantages et des limites :	<table><thead><tr><th>Avantages</th><th>Limites</th></tr></thead><tbody><tr><td>Etayant pour le professionnel</td><td>Focaliser son attention sur les préoccupations du soignant en perdant de vue celles du patient</td></tr><tr><td>Disposer de questions d'appui</td><td></td></tr><tr><td>Harmoniser les pratiques</td><td>Limitier la personne dans l'approfondissement de sa réflexion</td></tr></tbody></table>	Avantages	Limites	Etayant pour le professionnel	Focaliser son attention sur les préoccupations du soignant en perdant de vue celles du patient	Disposer de questions d'appui		Harmoniser les pratiques	Limitier la personne dans l'approfondissement de sa réflexion	
Avantages	Limites										
Etayant pour le professionnel	Focaliser son attention sur les préoccupations du soignant en perdant de vue celles du patient										
Disposer de questions d'appui											
Harmoniser les pratiques	Limitier la personne dans l'approfondissement de sa réflexion										
Outils pour favoriser l'expression	Certaines équipes utilisent des outils facilitateurs d'expression ⇒ Exemple : photo-expression = jeu de photos disposées sur une table → le patient et son entourage choisissent des photos en lien avec ce qu'ils souhaitent aborder ⇒ Exemple : jeu utilisé en pédiatrie auprès des patients atteints de mucoviscidose et leur entourage → présente des illustrations sur des thématiques du quotidien qui permettent de faciliter le dialogue et le recueil des besoins										
III- Du BEP au projet éducatif individualisé											
Analyse de l'information recueillie Mise en accord autour du projet éducatif individualisé BEP = temps de rencontre pour accéder à une compréhension partagée de la situation de la personne malade (+/- entourage) → identifier ensemble si cette situation pourrait être améliorée et comment. BEP permet de repérer des besoins = écarts entre la situation actuelle et une situation plus désirable pour le patient +/- entourage											
Besoin éducatif	La situation peut être améliorée par une intervention : - Qui vise le développement de compétences d'auto-soins et psychosociale - Qui repose sur une approche didactique prenant en compte l'ensemble des déterminants de la santé de la personne - Qui l'implique dans son apprentissage - Qui s'appuie sur ses ressources et cherche à renforcer son soutien psychosocial										
Compétences	La survenue d'une maladie chronique s'accompagne svt d'un sentiment de perte de contrôle ETP → renforcement des compétences de la personne malade chronique → augmentation de la perception de contrôle sur la maladie et sur sa vie 2 types de compétences : - d'Autosoins - d'Adaptation (=psychosociales) /!\ Distinction artificielle → compétences liées et interviennent de façon interconnectée dans les comportements de santé Ex : injection d'insuline (diabète type 1) : le patient doit savoir réaliser le geste mais aussi avoir confiance en lui et maitriser son stress (et parfois faire face aux regards des autres)										

Compétences d'autosoins	Connaissances, capacités à faire (pratiquer un geste de soins, mettre en place une auto-surveillance) capacités d'analyse, de prises de décisions, de résolution de problèmes, et de compétences relationnelles par rapport aux difficultés liées à la maladie et au ttt et aux répercussions qui en découlent But = Mettre en sécurité les personnes malades vis-à-vis de leur ttt Les compétences d'autosoins - Soulager les symptômes. - Prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, d'une automesure. - Adapter des doses de médicaments, initier un autotraitement. - Réaliser des gestes techniques et des soins. - Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie (équilibre diététique, activité physique, etc.). - Prévenir des complications évitables. - Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie. - Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent.
Compétences d'adaptations	De mieux en mieux prises en compte → tout aussi importantes pour soutenir les comportements de santé Permettent de faciliter la mobilisation des compétences d'autosoins Classification récente en 3 catégories : - Compétences émotionnelles - Compétences cognitives - Compétences relationnelles Les compétences d'adaptation - Se connaître soi-même, avoir confiance en soi. - Savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress. - Développer un raisonnement créatif et une réflexion critique. - Développer des compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles. - Prendre des décisions et résoudre un problème. - Se fixer des buts à atteindre et faire des choix. - S'observer, s'évaluer et se renforcer.
Synthèse du BEP	Temps important, permet de s'accorder avec la personne malade +/- entourage sur le projet éducatif individualisé : - Les objectifs de la PEC éducative définis à partir des besoins éducatifs et des ressources - Objectifs parfois formulés sous formes de compétences à acquérir ou renforcer - Le plan d'action (comprend les séances auxquelles la personne pourra participer) - La nature des informations à transmettre aux professionnels du parcours de soins (importance du consentement du patient +++) - La planification de l'évaluation du chemin parcouru à l'issue de cette démarche

En résumé :

Le BEP sert la compréhension de la situation du patient

Le projet éducatif se définit comme une dynamique de changement, de progrès

La personne et son entourage sont au centre du projet

Il repose sur l'équipe pluri-professionnelle

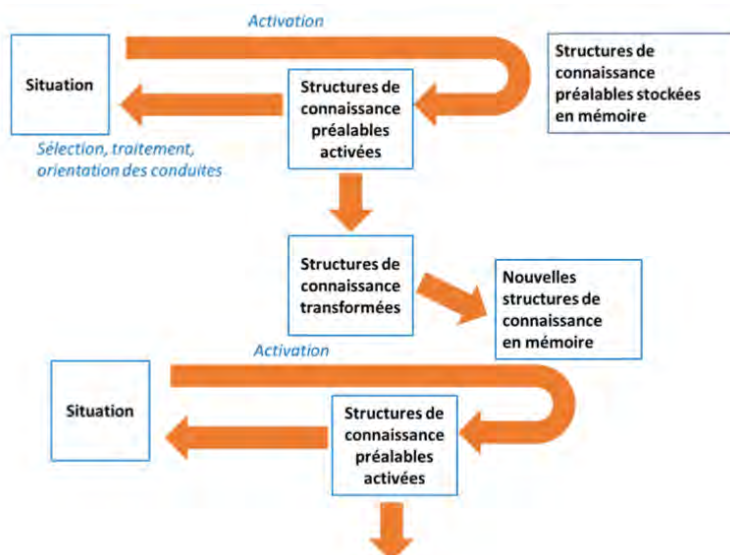
Les objectifs poursuivis sont communs à tous (équipe soignant ET la personne et son entourage)

C'est au niveau de la formalisation de la mise en œuvre (qui fait quoi) que se différencient les rôles de chacun

Les séances éducatives: Pour quoi faire? Quelle démarche pédagogique	
Les activités collectives identifiées dans le référentiel INPES	Il existe 6 situations significativement rencontrés dans la pratique de l'ETP Inscrites dans la situation 5 : - «Mettre en œuvre le plan d'action avec le patient et son entourage» → Les acteurs de l'ETP vont devoir développer des compétences organisationnelles relationnelles et surtout pédagogiques pour animer différentes activités collectives. Les activités collectives identifiées : • Animer des ateliers interactifs pour le patient dans le cadre de la démarche d'ETP : favoriser les apprentissages • Animer des activités de bien-être, des moments conviviaux : enrichir les possibilités de se ressourcer • Animer des temps d'expression, des groupes de parole avec les patients : favoriser l'expression et le partage des émotions.
Les séances éducatives dans la démarche il s'agit de la 3ème étape qui consiste à participer à des séances éducatives, mettre en œuvre le plan d'action personnalisé qui a été défini au décours du BEP	
Séances éducatives	⇒ Les actions à visée éducative (ou séances) viennent en réponse aux objectifs éducatifs convenus avec le patient et/ou l'aidant à l'issue du BEP ⇒ Elles peuvent être individuelles et/ou collectives ⇒ L'offre éducative s'adapte et évolue avec les besoins des bénéficiaires tout en tenant compte des possibilités des soignants: ressources (temps, effectifs, structures, compétences)
Comment apprend-on? Les approches pédagogiques en pratique éducative	
Pédagogie frontale	⇒ La pédagogie frontale part du principe que le sachant/pédagogue/l'éducateur = le soignant détient la clé du savoir et que son travail est de faire ingurgiter à l'apprenant=le patient qui ne sait rien ⇒ Elle est associée à quelque chose d'assez descendant voire d'injonctif

	Efficace si le soignant et le patient : • se posent les mêmes questions et ont les mêmes préoccupations • ont le même cadre de référence : notamment vocabulaire et façon de raisonner • produisent du sens de la même façon Limitée si : • même mots mais sens différent (vocabulaire médical, c'est souvent le 1er obstacle, les gens ne comprennent pas le sens des mots et ne vous le disent pas forcément pour ne pas vous décevoir c'est le fameux biais de désirabilité sociales, qui pousse le patient à donner, à voir et à entendre ce qu'il pense être la norme pour ne pas le décevoir le soignant) • mode de raisonnement différent • questions/préoccupations/attentes différente Le message ne sera entendu que si il est attendu et décodé de la même façon pour produire le même sens !
Pédagogie behavioriste = La théorie de Skinner	⇒ inventeur d'un dispositif de conditionnement opérant appelé la boîte de Skinner ⇒ matériel de laboratoire a simplifié l'étude des mécanismes de conditionnement notamment en favorisant le développement de modèles expérimentaux du comportement des organismes ⇒ conditionnement = apprendre une tâche de manière automatique ou réflexe par le biais de stimuli positif ou négatif selon un système de récompense ou de punition ⇒ L'individu aura tendance à adopter un comportement lui permettant d'éviter les renforcements négatifs et d'augmenter la survenue de renforcements positifs (la force de l'habitude, la répétition, la motivation à agir via le bénéfice perçue) ⇒ L'enseignement programmé consiste à proposer à l'élève des tâches de complexité croissante en fonction des réponses à chaque étape du processus Très efficace pour l'apprentissage des gestes techniques ou des réflexes Insuffisant pour le reste car ne prend pas en compte tous les processus mentaux qui entrent en jeu dans l'apprentissage (motivations, croyances, présupposés, désirs, intentions...)

Pédagogie socio
constructive



⇒ un problème à résoudre: boucle de déconstruction/construction

- 1) Analyse: vise à activer ses connaissances et à faire le point sur ce qu'il manque pour avancer dans la situation problème = phase de déconstruction assez désagréable mais que doit provoquer et accompagner l'éducateur
- 2) Reconstruire : sur la base de connaissances et outils **préexistants** et **nouveaux** (l'apprenant va aller chercher à cause de la situation problème qu'il a à résoudre) ⇒ restructuration d'un nouveau stock de savoir (+ enrichis)

⇒ Dans ce modèle, le pédagogue est là à chaque étape pour constater voir stimuler la confrontation avec la situation problème de son apprenant et puis il est là pour aider l'apprenant à faire ces constats qu'il impose, à l'aider à mobiliser des savoirs et à l'aider à aller chercher d'autres ressources pour au final constater avec lui la résolution du problème et le féliciter

- On apprend en s'appuyant sur ce que l'on sait déjà: Il n'y a pas de programme identique pour tous
- Le nouveau savoir ne s'installe que quand le savoir antérieur est périmé; nécessité de proximité du nouveau savoir avec l'ancien (pas de grand écart)
- Efficace pour enrichir un apprentissage
- Favorise la motivation + estime de soi

Accompagner la prise
de médicaments

- **Initiation:** le souci est souvent celui du défaut d'information des patients sur la balance bénéfice/risque des produits qui sont en jeu ⇒ Apporter l'information nécessaire (Frontal), répondre aux questions spécifiques que se pose le patient ⇒ stratégie DFD:
D=demander les questions que se pose le patient
F=fournir strictement les informations nécessaires
D=demander s'il a bien compris et vérifier que nous sommes d'accord
- **Implémentation:** oublis de prise liés à des défauts d'organisation ⇒ Conditionnement / automatismes (Behavioriste) (exple: Aider le patient à prendre ses comprimés du matin en associant ce geste à la préparation du café)
- **Maintenance (socioconstructiviste):** capacité à tenir le traitement dans la durée Ex : situations problèmes / cartes de Barrow

Pour la pratique



Théorie:

constructivisme

PIAGET



Idées clefs

- Devant une connaissance nouvelle, j'active une structure de connaissance préalable
- Il n'y aura d'apprentissage que si les connaissances préalables ont été restructurées par un conflit cognitif
- Si ce que j'apprend me conforte dans ce que je sais déjà = j'assimile et renforce seulement mes acquis = régulation homéostatique
- Besoin : « accommoder » c'est-à-dire, se modifier pour modifier mes conceptions antérieures à arriver à un nouvel équilibre

En pratique

- Favoriser le travail personnel puisque l'apprentissage nécessite un travail d'appropriation des notions transmises
- Favoriser la réflexion : prendre du recul, produire des idées nouvelles / aux acquis
- Favoriser la verbalisation : exprimer ce que l'on a compris = effort d'intégration, avant / pendant et après la formation
- Préférer l'apprentissage distribué / l'apprentissage massé dans le temps (modules)

Théorie:

Méthodes actives

ROUSSEAU,
DECROLY,FREINET,
MUCCHIELLI



Idées clefs

- L'action est occasion d'expérience à partir de laquelle l'apprenant peut procéder à une analyse
- Essai-analyse-hypothèse-vérification
- L'individu met en place un « tâtonnement expérimental »

En pratique

- Le formateur crée des situations de découverte dans lesquelles l'apprenant réalise son premier essai sans l'aide du formateur
- Donner des consignes précises
- Favoriser l'activité après la formation : inviter l'apprenant à se définir des objectifs d'application
- Faire définir des plans d'action, occasion de synthèse et de formalisation

Théorie: apprentissage coopératif Théorie du conflit sociocognitif Johnson, Johnson, Vigotski 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 241 568 421">Idées clefs</td><td data-bbox="568 241 1477 421"> ▪ En groupe = confronter les points de vue argumentation des solutions et/ou à compréhension des idées des autres, ▪ Conditions : engagement de chacun dans la tâche → même but → Climat positif dans le groupe </td></tr> <tr> <td data-bbox="379 421 568 640">En pratique</td><td data-bbox="568 421 1477 640"> ▪ Favoriser les activités en petits groupe de type atelier en présentant clairement la consigne et en choisissant l'exercice de manier adapter au groupe ▪ Se préoccuper de la dimension relationnelle du groupe (éviter les relations hiérarchiques ou statutaires dans les sous-groupes) </td></tr> </table>	Idées clefs	▪ En groupe = confronter les points de vue argumentation des solutions et/ou à compréhension des idées des autres, ▪ Conditions : engagement de chacun dans la tâche → même but → Climat positif dans le groupe	En pratique	▪ Favoriser les activités en petits groupe de type atelier en présentant clairement la consigne et en choisissant l'exercice de manier adapter au groupe ▪ Se préoccuper de la dimension relationnelle du groupe (éviter les relations hiérarchiques ou statutaires dans les sous-groupes)
Idées clefs	▪ En groupe = confronter les points de vue argumentation des solutions et/ou à compréhension des idées des autres, ▪ Conditions : engagement de chacun dans la tâche → même but → Climat positif dans le groupe				
En pratique	▪ Favoriser les activités en petits groupe de type atelier en présentant clairement la consigne et en choisissant l'exercice de manier adapter au groupe ▪ Se préoccuper de la dimension relationnelle du groupe (éviter les relations hiérarchiques ou statutaires dans les sous-groupes)				
Théorie: Psychologie sociale Lewin, Milgram, Moscovici 	Idées clefs: Un groupe de formation est un système complexe où: ▪ tous les participants peuvent être considérés comme « émetteurs et récepteurs d'influence » (Moscovici) ▪ Influence de la majorité et des experts ▪ L'influence de la norme du groupe ▪ Influence de l'unanimité ▪ L'influence de l'autorité ▪ L'influence de la minorité consistante (novateur)				
Théorie de la motivation Dewey, Bloom, Hameline 	• Pour qu'un projet de formation réussisse, il est nécessaire que chaque participant y trouve un moyen de réaliser son propre projet d'apprentissage • La formation passe par la compréhension de l'action ! De quoi ça parle ? De quoi il s'agit ? A quoi ça sert ? C'est la maîtrise du cadre par l'apprenant et notamment de l'utilité que le nouveau savoir acquis va apporter à cet apprenant qui est déclencheur de la mémorisation				
Théorie: Psychologie humaniste Knowles, Rogers 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1435 568 1615">Idées clefs</td><td data-bbox="568 1435 1477 1615"> ▪ la formation répond à d'autres besoins de la personne : "la curiosité, le besoin de savoir, le succès personnel, la mise à l'épreuve de soi, la réalisation de soi, la compétition" </td></tr> <tr> <td data-bbox="379 1615 568 1832">En pratique</td><td data-bbox="568 1615 1477 1832"> ▪ Créer un climat de confiance : règles strictes d'écoute mutuelle, de non jugement, de non- évaluation systématique, de droit à l'erreur et de respect de la confidentialité (Rogers). ▪ Développer des pédagogies ludiques : serious games, compétitions entre équipes, consignes qui rendent créatifs (diminution du contrôle, accentuation de l'action et mémorisation) </td></tr> </table>	Idées clefs	▪ la formation répond à d'autres besoins de la personne : "la curiosité, le besoin de savoir, le succès personnel, la mise à l'épreuve de soi, la réalisation de soi, la compétition"	En pratique	▪ Créer un climat de confiance : règles strictes d'écoute mutuelle, de non jugement, de non- évaluation systématique, de droit à l'erreur et de respect de la confidentialité (Rogers). ▪ Développer des pédagogies ludiques : serious games, compétitions entre équipes, consignes qui rendent créatifs (diminution du contrôle, accentuation de l'action et mémorisation)
Idées clefs	▪ la formation répond à d'autres besoins de la personne : "la curiosité, le besoin de savoir, le succès personnel, la mise à l'épreuve de soi, la réalisation de soi, la compétition"				
En pratique	▪ Créer un climat de confiance : règles strictes d'écoute mutuelle, de non jugement, de non- évaluation systématique, de droit à l'erreur et de respect de la confidentialité (Rogers). ▪ Développer des pédagogies ludiques : serious games, compétitions entre équipes, consignes qui rendent créatifs (diminution du contrôle, accentuation de l'action et mémorisation)				
Théorie: Psychologie cognitive	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1921 568 2011">Idées clefs</td><td data-bbox="568 1921 1477 2011"> ▪ Si une personne en situation d'apprentissage sait comment elle doit s'y prendre, elle a plus de chances d'apprendre efficacement </td></tr> </table>	Idées clefs	▪ Si une personne en situation d'apprentissage sait comment elle doit s'y prendre, elle a plus de chances d'apprendre efficacement		
Idées clefs	▪ Si une personne en situation d'apprentissage sait comment elle doit s'y prendre, elle a plus de chances d'apprendre efficacement				

Flavell, Vermersch



	- Les synthèses (sélection des informations à conserver après débat) et la formalisation (ce qui donne forme au contenu) renforcent l'appropriation donc la mémorisation - L'analyse des processus métacognitifs enrichit les stratégies
En pratique	- Accompagner la méthodologie d'apprentissage (guide méthodologique, conseils et consignes précises de réalisation, analyse des méthodes de résolution) - Aider l'apprenant à repérer ses stratégies d'apprentissage (discussion sur ses modes préférentiels) - Varié ses modalités de présentation des données pour s'adapter aux divers styles d'apprentissage (textes, schémas, graphiques)

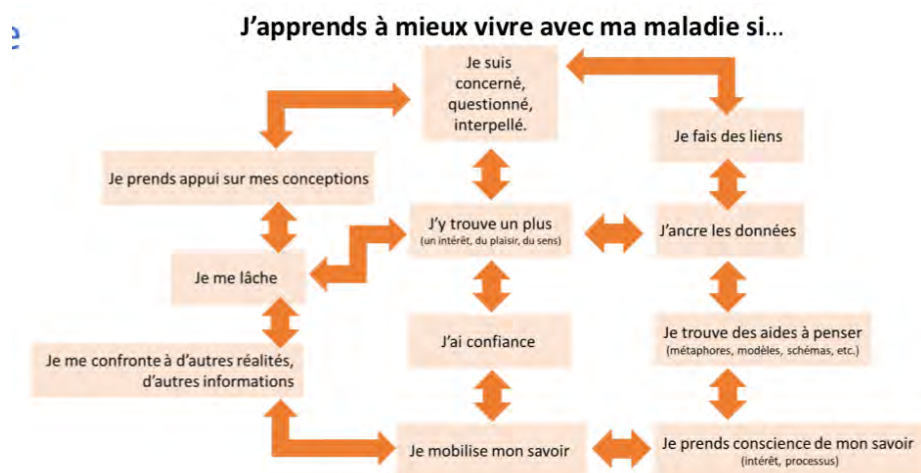
Une pédagogie "sur mesure" pour l'ETP (A Giodan)

⇒ Dans les limites des pédagogies dites classiques (frontale, behavioriste et constructiviste) conduisent à envisager une approche nouvelle spécifique à l'ETP

⇒ Elle repose sur 3 bases complémentaires:

- Multiplier les interactions entre le patient, son environnement, son corps, sa pathologie, son traitement, son entourage, les soignants
- et le système de soins
- Prendre en compte ses multiples dimensions: émotions, ressentis, regard, façon de s'impliquer dans la maladie et son traitement
- Pédagogie systémique basée sur la transformation des conceptions de la personne (environnement didactique)

Un environnement didactique pour l'ETP (A Giodan)



Que retenir pour la pratique?

- Le patient apprend à partir de ses conceptions, de ce qu'il est et de ce qu'il sait, c'est le seul outil dont il dispose
- L'appropriation d'un savoir ou d'un changement de comportement n'est jamais le seul fait de l'individu ou de son environnement mais de l'émergence des interactions entre les 2
- Le rôle du soignant éducateur est d'accompagner le patient et de veiller à mettre en place pour lui un environnement didactique stimulant (ressources éducatives, outils, des échanges de groupes pour favoriser les apprentissages)

En ETP, on va privilégier des méthodes pédagogiques cohérentes avec:

- Les finalités poursuivies : renforcement du pouvoir d'agir et de l'autonomie de la personne (patient ou aidant).
- La reconnaissance des savoirs des participants, experts de leur vie avec la maladie. ▪ La prise en compte de la singularité de chaque participant : qui il est, son histoire, l'environnement dans lequel il s'inscrit...
- L'importance accordée à la relation entre soignant ou patient-intervenant et patients et aidants : partenariat, chacun apprend de l'autre.

Animer un groupe

La fiche pédagogique de séance (= conducteur)	
1ère étape d'une séance éducative : la préparer ➤ Document qui formalise les éléments clés de la séance ➤ Facilite : - La tâche de l'intervenant - La cohérence dans le déroulement - L'évaluation de la séance	
Contenu général	Le cadre de la séance, le public visé, les modalités d'animation, les objectifs, le déroulement des différentes séances pédagogiques, le matériel nécessaire, les techniques et outils d'animation envisagés, les modalités d'évaluation.
Préciser le cadre de la séance	▪ A qui s'adresse-t-elle ? → age, type de pathologie, entourage, taille du groupe ?... ▪ Quelle durée ? Quel moment ? La place dans le parcours de soin ? → besoin d'avoir fait d'autres séances en amont... ▪ Quel lieu ? ▪ Quel(s) animateur(s) ? ▪ Quelles modalités pratiques pour l'inscription ? ▪ Comment avoir des informations sur le(s) participant(s) en amont ?
Définir les objectifs	<u>But de la séance</u> : donne l'orientation générale, non évaluable <u>Objectifs généraux</u> (défini l'intention, précise l'intérêt de la séance) <u>et spécifiques</u> (précisent les actions à mettre en œuvre pour contribuer à l'objectif général) : ▪ Evaluables et précis ▪ Centrés sur les participants (« a l' » issue de la séance, le patient, l'aidant aura. », « a l'issue de la séance, le patient, l'aidant sera en mesure de... ») <u>Objectifs opérationnels</u> : précisent les tâches à effectuer : + les ils sont précis, + l'évaluation sera facile
Construire le déroulement	Le déroulement est conçu de façon à : ➤ Permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est donné ➤ Être réalisable dans le temps dont on dispose ➤ Être adapté aux personnes qui participeront à l'atelier Il comprend : - Les différentes étapes de la séance - Les techniques d'animation ou outils pédagogiques utilisés pour chaque étape Une technique = jamais une fin en soi, mais plus un moyen d'atteindre un objectif préalablement défini - Les modalités prévues pour l'évaluation (animation et atteinte des objectifs) → il faut au moins proposer aux participants de s'exprimer à la fin de la séance → Cadre que l'on se donne, mais pour mieux le modifier au besoin, il ne faut pas mettre l'intervenant dans un cadre trop rigide
Identifier le matériel dont on a besoin	- Tables, chaises, possibilités de réorganiser la salle - Papier, stylos, feutres, ciseaux, post-it... - Tableaux blancs, de papier - Matériel vidéo, audio - Outils pédagogiques - Supports éventuels à remettre à l'issue de la séance - Supports existants - Supports à créer → parfois besoin de créer les outils nous-mêmes
Prévoir la traçabilité et le partage d'info	• Comment garder une trace du fait que la séance a eu lieu, de qui a participé ? • Quelles infos partager sur ce qui s'est passé pdt la séance pour un patient donné ? • Comment ? Avec qui ?

Les outils et les techniques

On privilégie des méthodes pédagogiques cohérentes avec :

- Les **finalités poursuivies** : renforcement du pouvoir d'agir du patient, de son autonomie
- La **reconnaissance** des savoirs des patients, experts de leur vie avec la maladie
- La prise en compte de la **singularité** de chaque patient : qui il est, son histoire, l'environnement dans lequel il s'inscrit
- L'importance accordée à la **relation entre soignant ou patient-intervenant et patients** : partenariat, chacun apprend de l'autre

Adéquation avec :

- L'objectif poursuivi (la technique n'est qu'un outil)
- Le temps dont on dispose
- Les particularités du public (/!\ si difficultés avec l'écrit)
- Ses propres besoins/compétences pour l'animation (choisir une technique avec laquelle on est à l'aise)

3 grandes catégories :

- **Instaurer une dynamique de groupe**
- **Connaître le groupe et se connaître**
- **Construire et produire en groupe**

Ressources :

- Alain Douiller : « 25 techniques d'animation pour promouvoir la santé »
→ Classement des techniques d'animation selon l'objectif poursuivi (certaines techniques servent plusieurs objectifs à la fois)
- Techniques d'animation en promotion de la santé (CRES Languedoc Roussillon)

**Comment
choisir une
technique
d'animation ?**

Pour instaurer une dynamique de groupe

Permettre de se présenter , de faire connaissance	Présentation croisée, CV imaginaire, portrait chinois, blason de présentation
Favoriser un climat de confiance , une bonne dynamique de groupe	Présentation croisée, CV imaginaire, portrait chinois, blason de présentation photolangage®
Favoriser la créativité et l'imaginaire	Portrait chinois, CV imaginaire

Présentation croisée : permet aux membres d'un groupe de faire connaissance 2 par 2

CV imaginaire : se présenter de façon créative

Portrait chinois : se présenter sous un jour inhabituel et de façon originale en se comparant par ex à une fleur, un animal, une couleur...

Blason de présentation : se présenter sous un angle plus structuré

Photolangage : fait appel à un support visuel

Connaître le groupe, se connaître

Recueillir les besoins et attentes	Présentation croisée, Focus Groupe, blason de présentation, Petits papiers
Faire exprimer les représentations	Blason des idées, brainstorming, photolangage ®; autour du mot, mur écrit, focus groupe, ciné santé, Jeu de la ligne, tour de table des idées, Pyramide, carte mentale, abaque de Régnier, petits papiers
Identifier les codes de communication	Écouter/écouter

Blason des idées : repose sur un support graphique, pour aider à structurer la pensée et à échanger dans le groupe

Brainstorming (=tempête de cerveau) : fait appel à la spontanéité, production rapide d'idées, de réflexion ou de discussion sur un sujet donné

Autour du mot : implique la participation de tous les membres du groupe, fait appel à l'écrit, favorise l'expression personnelle et à la prise de parole en groupe

Mur écrit : permet de récupérer dans un temps assez court les opinions de toutes les personnes du groupe, favorise l'implication et les interactions

Focus groupe : permet d'obtenir des opinions, cerner les représentations sur un sujet.

L'intervenant oriente le sujet sur un thème et invite le groupe à approfondir et à échanger.

Ciné santé : repose sur la projection d'un film suivi d'un débat pour exprimer ses ressentis, ses interprétations et ses idées. Permet une prise de recul et une analyse sur un sujet défini

Jeu de la ligne : invite chaque membre du groupe à se positionner par rapport à une affirmation, il

	interroge sur les idées reçues, les croyances, permet de favoriser le débat et la confrontation des points de vue Tour de table des idées : permet à tout le monde de participer, souvent en binôme, pour produire une idée ou une proposition jusqu'à épuisement. Technique très ludique qui apporte bcp d'émulation et permet de travailler rapidement. La pyramide : permet de construire un consensus dans le groupe. Chacun sera invité à s'exprimer et à argumenter. Carte mentale : permet de produire une représentation visuelle d'un sujet à partir de la réflexion et des échanges du groupe Abaque de Régnier : ressemble au jeu de la ligne, basé sur un outil + visuel, de type carton vert ou rouge, pour représenter son opinion sur un sujet et ouvrir le débat au sein du groupe Les petits papiers : font aussi appel au passage à l'écrit pour stimuler des idées sur un thème dans un temps assez court en faisant s'exprimer tout le monde. On s'inspire des idées des autres pour stimuler sa propre réflexion et production. Ecoutant/écouté : jeu de rôle qui permet de faire une expérience d'écoute ou de non-écoute et permet ainsi d'identifier les éléments déterminants d'une bonne écoute. <table border="1" data-bbox="507 741 1310 1081"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produire, construire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Favoriser le débat, confronter les idées</td><td>Blason des idées, autour du mot, pour/contre, ciné santé, Jeu de la ligne, Pyramide, doutes et certitudes, abaque de Régnier, scénario catastrophe, jeu de la tentation</td></tr> <tr> <td>Déterminer des priorités, des objectifs</td><td>Focus groupe, blason des idées, brainstorming, mur écrit, pyramide, petits papiers</td></tr> <tr> <td>Favoriser des consensus</td><td>Focus groupe, pyramide</td></tr> <tr> <td>Produire des propositions, des solutions, des modalités d'action</td><td>Blason des idées, brainstorming, mur écrit, focus groupe, tour de table des idées, jeu des enveloppes, petits papiers, scénario catastrophe, jeu de la tentation</td></tr> <tr> <td>Solliciter des avis, évaluer</td><td>Focus groupe, échelle du temps, Technique d'évaluation orale</td></tr> </tbody> </table> Pour/contre : débat contradictoire permettant de réfléchir à des opinions adverses et d'apprendre à débattre en respectant son interlocuteur Scénario catastrophe : permet de travailler sur l'échec pour identifier des solutions et des modalités d'action. Technique très ludique et très productive. Doutes et certitudes : permet de cerner les connaissances et mutualiser les savoirs Jeu de la tentation : repose sur un jeu de rôle qui permet de comprendre le rôle des influences et de réfléchir à la façon d'y résister. Jeu des enveloppes : permet de produire en groupe des idées et des solutions de façon stimulante avec un travail de réflexion d'abord en sous-groupe. Les participants sont repartis en autant de sous-groupe qu'il y a de question à résoudre et chaque question est marquée sur une enveloppe. Le groupe glisse sa réponse dans l'enveloppe sans regarder les réponses des autres groupes qui y figurent déjà avant la mise en commun.	Produire, construire		Favoriser le débat, confronter les idées	Blason des idées, autour du mot, pour/contre, ciné santé, Jeu de la ligne, Pyramide, doutes et certitudes, abaque de Régnier, scénario catastrophe, jeu de la tentation	Déterminer des priorités, des objectifs	Focus groupe, blason des idées, brainstorming, mur écrit, pyramide, petits papiers	Favoriser des consensus	Focus groupe, pyramide	Produire des propositions, des solutions, des modalités d'action	Blason des idées, brainstorming, mur écrit, focus groupe, tour de table des idées, jeu des enveloppes, petits papiers, scénario catastrophe, jeu de la tentation	Solliciter des avis, évaluer	Focus groupe, échelle du temps, Technique d'évaluation orale
Produire, construire													
Favoriser le débat, confronter les idées	Blason des idées, autour du mot, pour/contre, ciné santé, Jeu de la ligne, Pyramide, doutes et certitudes, abaque de Régnier, scénario catastrophe, jeu de la tentation												
Déterminer des priorités, des objectifs	Focus groupe, blason des idées, brainstorming, mur écrit, pyramide, petits papiers												
Favoriser des consensus	Focus groupe, pyramide												
Produire des propositions, des solutions, des modalités d'action	Blason des idées, brainstorming, mur écrit, focus groupe, tour de table des idées, jeu des enveloppes, petits papiers, scénario catastrophe, jeu de la tentation												
Solliciter des avis, évaluer	Focus groupe, échelle du temps, Technique d'évaluation orale												
Exemple	Exemple de carte conceptuelle auprès d'enfants asthmatiques pour les aider à réfléchir sur le rôle de leurs médicaments et le bon moment pour les prendre. 												
Apprentissages de gestes	→ Apprentissage de gestes → Compréhension de mécanismes physiopathologiques (démonstration, simulation, manipulation d'objets...) 												

Anticipation et résolution de problèmes	- Etudes de cas - Enigmes - Personnage mosaïque (personnage imaginaire auquel on fait vivre des situations problématiques) - Mises en situations - Jeux sérieux <i>Ex : maison playmobil → montrer ce qui peut être dangereux pour enfant asthmatique dans la maison</i> - Carte de Barrows : illustrent des situations problématiques que les patients sont susceptibles de rencontrer dans leur quotidien. Il y a différentes possibilités de réagir, les participants sont invités à réfléchir à la façon dont eux-même réagiraient, et au dos de chaque carte réponse se trouve les conséquences de leur choix, qui peuvent ensuite faire l'objet d'échanges et de réflexion. - Cartes symptômes : permet d'apprendre à repérer des signes d'alerte  
Soutenir les compétences psycho-sociales	- Jeux de rôle - Marionnettes - Ambassadeur - Mallette comète (Lien) 
La dynamique de groupe (R. Mucchielli)	Un groupe représente plus que la totalité de ses membres. - Fonctionnement propre - Capacités d'adaptation et de chgt des individus potentialisé - Buts communs - Facteurs affectifs, sentiments collectifs - Effet de posture de l'intervenant sur la performance du groupe Non directivité (confiance dans le groupe et la capacité des personnes à assumer le dvp de leurs compétences), équilibre entre le cadre et un espace de liberté, garant du cadre de travail bienveillant et chaleureux
Responsabilités de l'animateur	• Etre attentif à ses propres attitudes, comportements et paroles vis-à-vis du groupe • Etre garant de la qualité des relations entre les mb du groupe : respect, écoute, non-jugement • Veiller à la qualité de l'environnement de travail • Reconnaissance et valorisation de l'expertise des patients • Aide à la construction collective de savoir • Apports, si nécessaire en complément, de ses propres savoirs, en fonction de qu'a déjà élaboré le groupe
Démarrer une activité de groupe	• Adopter une position d'accompagnateur plutôt que d'expert : accompagner la progression du groupe, il ne s'agit pas tant de transmettre des savoirs mais de veiller à produire des effets de coopération, émulation, valorisation interne → inverse d'une pédagogie descendante • Définir le cadre de l'intervention : énoncer les règles du groupe dès le début pour permettre de poser un cadre sécurisant et bienveillant, basé sur l'écoute, le respect mutuel et la confidentialité • Énoncer clairement les objectifs de la séance : pour ne pas avoir de sentiment de manipulation • Préciser la forme et les modalités de travail • S'assurer systématiquement de la bonne compréhension : demander si il y a des questions ou besoin de reformuler

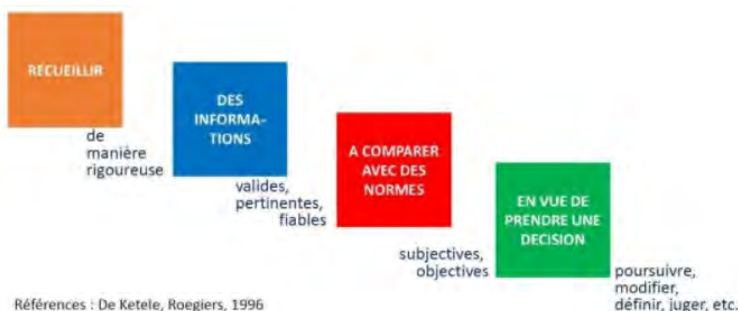
Entretenir la dynamique de travail collectif	• Adopter une posture d'écoute attentive et bienveillante • Garantir une bonne répartition des temps de parole (limite les bavards, encourager les timides) • Recentrer les discussions • Reformuler ou faire reformuler • Relancer les échanges avec des questionnements • Si une affirmation pose pb : ne pas se mettre en opposition, mais plutôt demander l'avis du groupe • Recherche les points d'accord/désaccord, les nuances en respectant les positions de chacun • Veiller au respect des horaires annoncés
Dimension physique	Le regard est très important : il est essentiel de regarder chacun des mb du groupes, ne pas regarder une ou plusieurs personnes = les exclure, les désinvestir La dynamique corporelle : pas trop statique, plutôt debout, appuyer son discours de gestes, trouver la bonne distance avec les participants
Préparation matérielle	- Taille de la salle - Configuration : disposition des tables et chaises (configuration en cercle ou en U) - Température de la salle (bonne aération, bonne acoustique, bonne luminosité, bonne insonorisation) - Matériel nécessaire à l'animation - Accueil-pauses (café, collation)
Co-animation	Avantages : moins de fatigue, facilite la dynamique de groupe, évaluation de la séance Veiller à être en phase sur : - Les objectifs - Les valeurs/représentations en lien avec le sujet - Le déroulé - Les rôles respectifs de chacun dans la co-animation

Education thérapeutique

Chapitre 3 : Evaluation en ETP

L'évaluation en ETP : définition et objectifs

- processus qui consiste à recueillir de manière rigoureuse des infos que l'on va comparer à des normes (subjectives ou objectives) => BUT : prendre une décision
- repose sur la notion d'un jugement de valeur sans connotations péjoratives
 - réajuster une prise en charge
 - être conforté dans des pratiques
 - identifier des pistes pour améliorer des pratiques



Evaluation individuelle

- évaluation du parcours éducatif proposé au patient
 - réalisée tout au long de la prise en charge
 - **commence lors d'un bilan éducatif partagé initial** => recueil d'infos en vue de prendre une décision qui correspond au fait de s'accorder sur un projet éducatif individualisé
 - **se poursuit pendant les temps d'ETP** => recueil du progrès afin d'éventuellement réajuster la prise en charge
 - **se poursuit lors du bilan éducatif partagé final** => recueil d'infos sur les effets produits par la démarche éducative (savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir), sur les comportements adaptatifs et sur les indicateurs de santé
 - **OBJECTIF** : valoriser les ressources mobilisées pour faire face aux difficultés de la maladie chronique et réajuster la prise en charge lorsque c'est nécessaire
 - conçue dans un esprit collaboratif
 - c'est un temps éducatif en soi
 - inviter le patient à porter un regard sur son parcours, son évolution et ses progrès => participe au développement des compétences psycho-sociales
 - intervenant : écouter + questionnement auto-réflexif + valoriser l'expérience, les apprentissages et les découvertes ainsi que les ressources mobilisées du patient
- => synthèse adressée avec consentement du patient aux professionnels de santé

Evaluation des programmes

- loi hôpital, santé et territoire de 2009 : inscrit l'ETP dans le parcours de soin + préconise sa mise en oeuvre sous forme de programmes autorisés par l'ARS
- programme doit être conforme au cahier des charges national => autoévaluation annuelle
- autoévaluation s'inscrit dans une démarche qualité d'amélioration continue des pratiques

Evaluation annuelle

Activité globale du programme :

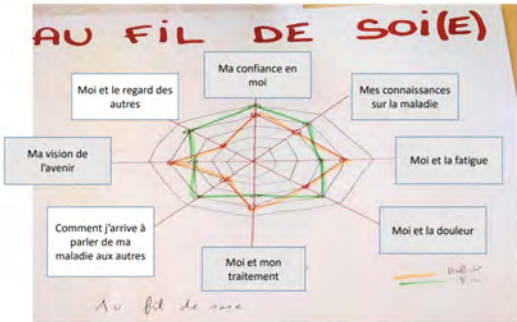
- équipe recueille et analyse les indicateurs quali et quanti

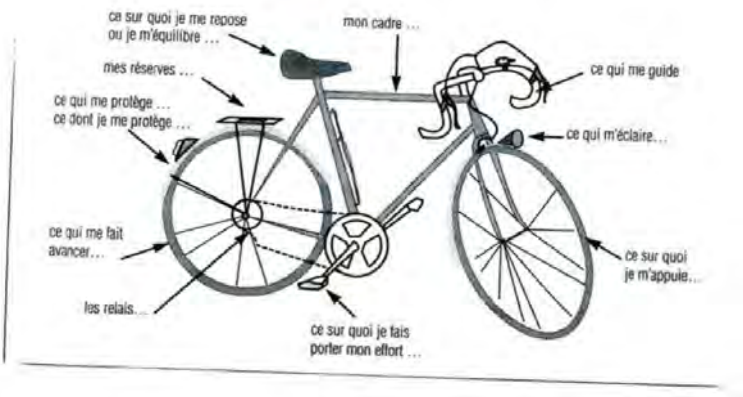
		- indicateurs quanti : choisis par les ARS et peuvent varier d'une région à l'autre => déterminer les enveloppes de financement - touchent au nombre de patients engagés l'année précédente - touchent au nombre de parcours éducatifs complets - touchent au nombre d'intervenants concernés dans la mise en oeuvre du programme - touchent parfois au nombre de patients experts
	Evaluation du processus	- choisir les sujets qui questionnent concernant les pratiques et la façon de procéder - s'intéresse à : l'organisation des étapes + l'adaptation du programme aux besoins - s'intéresse aussi aux séances : contenu, adaptation des outils, compétences des intervenants, modalités de partage de l'info, coordination du programme => identifier ce qui fonctionne bien ou ce qu'il y aurait à améliorer
	Evaluation des effets	- effets chez les bénéficiaires : compétences dans les comportements de santé et indicateurs, niveau de satisfaction => identifier les pistes d'amélioration - effets sur l'équipe : fonctionnement, niveau de satisfaction - intégration du programme dans l'offre de soin : accessibilité et visibilité
	Evaluation quadriennale	- démarche de bilan des 3 dernières années - synthèse des auto-évaluations annuelles - rend compte de l'évolution du programme - permet de prendre des décisions sur la poursuite du programme ou non, sur d'éventuels changements - si poursuite : rapport synthétique d'auto-évaluation quadriennal + dossier de demande de renouvellement envoyés à ARS
Résumé	NDLR : désolée vraiment il se répète non stop c'est insupportable - évaluation : démarche participative organisée et pilotée par le coordinateur - prise en compte des points de vue de tous les intervenants de l'équipe mais aussi ceux des bénéficiaires et des professionnels de santé impliqués - progressive et évolutive : recueil annuel d'indicateurs	
Les étapes de la démarche d'évaluation		
3 étapes : - ce que l'on souhaite évaluer + objectifs d'évaluation => quelles sont les questions qui seront posées? - comment on évalue, par quelle méthode ou quel dispositif, données recueillies et indicateurs pertinents => qui réalise cette évaluation et à quel moment - analyse des données => jugement par rapport à des normes définies au préalable => PRISE DE DÉCISION		
1ère étape : Définition des objets d'évaluation	- mise en oeuvre de pratiques éducatives pour produire des effets sur les bénéficiaires => on espère que les effets seront positifs - effets positifs sur : - connaissances + savoir-faire => capacités développées pour accomplir un certain nombre d'actions	

	○ attitudes => permettre de réagir en situation réelle ○ aptitude à se projeter => amélioration de l'état de santé au sens large ○ chez les professionnels : cohérence dans l'équipe, lutte contre les messages contradictoires 4 «niveaux» d'apprentissage Savoir =Connaissances Savoir Faire = Capacités acquises dans la mise en œuvre (en milieu sécurisé) Savoir être = Attitudes à développer = (réagir en situation réelle) Savoir devenir = capacité de se mettre en projet et d'y aboutir Paramètres et indicateurs de santé Physiques - Psychologiques – Sociaux Qualité de vie <table><tr><th>PRATIQUES et CONTENUS</th><th>EFFETS NIVEAU 1</th><th>EFFETS NIVEAU 2</th></tr><tr><td>Posture des soignants Organisation du parcours éducatif Coordination Communication BEP Séances (techniques, outils, supports, ...)</td><td>Sur le patient/ les proches COMPETENCES COMPORTEMENTS Sur les professionnels de l'équipe</td><td>Sur le patient : ETAT DE SANTE(s) Sur les acteurs du parcours de soins et l'intégration dans le parcours de soin</td></tr></table>	PRATIQUES et CONTENUS	EFFETS NIVEAU 1	EFFETS NIVEAU 2	Posture des soignants Organisation du parcours éducatif Coordination Communication BEP Séances (techniques, outils, supports, ...)	Sur le patient/ les proches COMPETENCES COMPORTEMENTS Sur les professionnels de l'équipe	Sur le patient : ETAT DE SANTE(s) Sur les acteurs du parcours de soins et l'intégration dans le parcours de soin																								
PRATIQUES et CONTENUS	EFFETS NIVEAU 1	EFFETS NIVEAU 2																													
Posture des soignants Organisation du parcours éducatif Coordination Communication BEP Séances (techniques, outils, supports, ...)	Sur le patient/ les proches COMPETENCES COMPORTEMENTS Sur les professionnels de l'équipe	Sur le patient : ETAT DE SANTE(s) Sur les acteurs du parcours de soins et l'intégration dans le parcours de soin																													
2ème étape : Comment on évalue?	● on choisit donc le ou les critères observables : préciser et affiner les objets d'évaluation ● on choisit ensuite les points de vue que l'on va recueillir ● on choisit aussi à quel moment du parcours de soin on réalise cette évaluation																														
3ème étape : Analyse et prise de décision	● identifier ce qui s'est amélioré et ce qui reste difficile auprès du patient ● voir ce que l'on va mettre en oeuvre pour la suite ● décider à quel moment on analyse, qui va analyser ● décider aussi des normes de qualité																														
Illustrations, outils, exemples																															
Évaluation d'une compétence d'auto soin	● réalisation de mesure de la glycémie capillaire ● plusieurs dimensions : réalisation du geste technique, sentiment de capacité, confiance en soi de la personne qui réalise le geste, mise en application pratique de la surveillance au quotidien... ● on choisit le point de vue, le moment où on évalue et les outils de recueil de données <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Il s'est lavé les mains o/n Il a changé sa lancette o/n Il a réglé la profondeur de son auto piqueur o/n Il pique au bon endroit o/n</td></tr><tr><th>Compétence</th><th>Choisir le critère qui rend cette compétence observable</th><th>Choisir le point de vue à privilégier</th><th>Choisir qui remplit le document</th><th>Choisir le moment</th><th>Outil sélectionné</th></tr><tr><td>Savoir réaliser une glycémie capillaire</td><td>Mise en pratique du geste</td><td>Soignant</td><td>Soignant</td><td>Pendant la séance individuelle</td><td>Grille de geste Je me sens capable de réaliser ce geste seul 0 →10</td></tr><tr><td>Se sentir capable de réaliser son geste de soins</td><td>Expression par le patient de son sentiment sur sa capacité à réaliser le geste seul</td><td>Patient</td><td>Patient</td><td>Lors du BEP en fin de programme</td><td>EVA sur 10 L'ASG est difficile à mettre en place dans certaines situations (manque de temps le midi, impact du regard des autres ...)</td></tr><tr><td>Mettre en place son autosurveillance glycémique capillaire au quotidien</td><td>Nombre de glycémies capillaires réalisées Expression des freins/leviers par le patient de ses pratiques d'autosurveillance</td><td>Soignant Patient</td><td>Soignant Soignant</td><td>Lors d'un entretien de suivi</td><td>Rec Ver Du</td></tr></table>						Il s'est lavé les mains o/n Il a changé sa lancette o/n Il a réglé la profondeur de son auto piqueur o/n Il pique au bon endroit o/n	Compétence	Choisir le critère qui rend cette compétence observable	Choisir le point de vue à privilégier	Choisir qui remplit le document	Choisir le moment	Outil sélectionné	Savoir réaliser une glycémie capillaire	Mise en pratique du geste	Soignant	Soignant	Pendant la séance individuelle	Grille de geste Je me sens capable de réaliser ce geste seul 0 →10	Se sentir capable de réaliser son geste de soins	Expression par le patient de son sentiment sur sa capacité à réaliser le geste seul	Patient	Patient	Lors du BEP en fin de programme	EVA sur 10 L'ASG est difficile à mettre en place dans certaines situations (manque de temps le midi, impact du regard des autres ...)	Mettre en place son autosurveillance glycémique capillaire au quotidien	Nombre de glycémies capillaires réalisées Expression des freins/leviers par le patient de ses pratiques d'autosurveillance	Soignant Patient	Soignant Soignant	Lors d'un entretien de suivi	Rec Ver Du
					Il s'est lavé les mains o/n Il a changé sa lancette o/n Il a réglé la profondeur de son auto piqueur o/n Il pique au bon endroit o/n																										
Compétence	Choisir le critère qui rend cette compétence observable	Choisir le point de vue à privilégier	Choisir qui remplit le document	Choisir le moment	Outil sélectionné																										
Savoir réaliser une glycémie capillaire	Mise en pratique du geste	Soignant	Soignant	Pendant la séance individuelle	Grille de geste Je me sens capable de réaliser ce geste seul 0 →10																										
Se sentir capable de réaliser son geste de soins	Expression par le patient de son sentiment sur sa capacité à réaliser le geste seul	Patient	Patient	Lors du BEP en fin de programme	EVA sur 10 L'ASG est difficile à mettre en place dans certaines situations (manque de temps le midi, impact du regard des autres ...)																										
Mettre en place son autosurveillance glycémique capillaire au quotidien	Nombre de glycémies capillaires réalisées Expression des freins/leviers par le patient de ses pratiques d'autosurveillance	Soignant Patient	Soignant Soignant	Lors d'un entretien de suivi	Rec Ver Du																										
Evaluation de la communication autour du programme	● aspect primordial si on veut optimiser l'orientation vers le programme																														

Choisir ce que vous souhaitez évaluer	Choisir le critère observable	Choisir le point de vue à privilégier	Choisir qui remplit le document	Choisir le moment	Outil sélectionné
La communication sur le programme	Mise à jour de la fiche EPHORA	Coordonnateur		tous les 2 ans	Synthèse dans le rapport d'activité
	Ressenti sur le niveau d'information concernant le programme	Acteurs du parcours de soin	Acteurs du parcours de soin	tous les 4 ans	Autoquestionnaire
	Diversité de provenance des patients adressés vers le programme	Equipe	Secrétaire	A chaque inclusion dans le programme	Tableau de bord

Tableau récapitulatif d'outils pour évaluer les compétences psychosociales	L'outil	Le moment	Le point de vue	Qui le remplit	Exemple	Remarques
	Grille d'observation	Pendant une séance collective	Le patient ou l'intervenant	L'intervenant ou un patient	Si la compétence visée dans la séance est « Exprimer ses émotions », la grille d'observation peut comprendre : • des éléments qualitatifs : prises de notes des mots relatifs aux émotions exprimées par les patients • des éléments quantitatifs : échelle allant de « pas d'émotions exprimées » à « grande expression d'émotions »	Si plusieurs professionnels différents utilisent le même outil, il est nécessaire qu'un travail préalable permette de s'entendre sur ses modalités de remplissage. L'outil peut être utilisé pour évaluer un groupe ou un seul patient. Un patient du groupe peut être invité à remplir le document.
	Fiche de suivi individuel	Pendant et fin de programme	Le patient ou l'intervenant	L'intervenant	Une même compétence peut être évaluée à plusieurs étapes pendant le déroulement d'un programme.	Le professionnel qui réalise cette évaluation doit être, si possible, le même du début à la fin.
	Journal de bord, passeport...	Au cours du programme	Le patient	Le patient	Carnet avec des exemples sur des situations de sa vie quotidienne, des estimations des compétences qu'il a développées.	Cet outil est conservé par le patient tout au long du programme. Il peut le remplir quand il en a envie. Les intervenants peuvent également inviter les patients à le remplir à des moments particuliers. Il peut comporter des questions ouvertes ou fermées.
	Synthèse d'entretien individuel	Lors d'un entretien individuel spécifique de bilan intermédiaire ou final	Le patient ou l'intervenant	L'intervenant	L'intervenant écrit une synthèse sur les évolutions des compétences psychosociales du patient.	La forme du document doit être structurée et commune à toute l'équipe des intervenants. Le contenu est personnalisé pour chaque patient.

Outil au fil de soi(e)	construit par un patient schizophrène et le soignant => évaluation de sa progression dans différents domaines\$
	

Symbolique de la bicyclette	auto évaluation des ressources
	

Evaluation des connaissances du patient

Propositions	Mettre une croix dans la case de votre choix		Mettre une croix dans la case de votre choix. De votre réponse vous êtes :				
	Vrai	Faux	Pas sûr	Peu sûr	Assez sûr	Sûr	Très sûr
1. Dans la mucoviscidose, les sécrétions bronchiques sont collantes, visqueuses.							
2. L'ECBC (Examen Cyto-Bactériologique des Crachats) recherche et identifie des bactéries dans les sécrétions des bronches.							
3. Une toux productive plus fréquente et/ou des crachats plus foncés sont des signes d'alerte d'une infection bronchique.							
4. Les résultats de l'ECBC sont utiles au médecin pour choisir l'antibiotique à prescrire.							
5. Les antibiotiques peuvent être arrêtés au bout de 7 jours en cas d'amélioration, même s'ils sont prescrits 14 jours.							
6. L'activité physique doit être restreinte chez un enfant atteint de mucoviscidose.							
7. Les EFR (Explorations Fonctionnelles Respiratoires) permettent de suivre l'évolution de la capacité respiratoire (souffle).							
8. L'atmosphère tabagique favorise l'inflammation des bronches (tabagisme passif).							
9. Être présent à la maison lors des travaux de rénovation ou de réfection de tapisserie est sans risque pour l'enfant atteint de mucoviscidose.							
10. Boire de l'eau dans la journée aide à fluidifier les sécrétions bronchiques.							
11. Le vaccin contre la grippe est déconseillé pour les enfants atteints de mucoviscidose.							
12. Se laver régulièrement les mains limite la transmission des germes (bactéries, virus).							

Avant je croyais que

Maintenant je sais que

Avant je faisais....

Maintenant je fais....

Avant je me sentais....

Maintenant je me sens...

BEP final

- évaluer les connaissances acquises et les changements mis en place dans leur quotidien
- recueillir les suggestions d'amélioration du programme
- identifier les besoins

Les pièges à éviter

- objectif de l'évaluation : améliorer la qualité du programme et pas prouver que ce qui est fait est bien
- choisir moins d'objets mais mener à terme la démarche plutôt que de choisir trop d'objets et ne pas avoir le temps de regarder les données recueillies
- ne pas évaluer trop tôt l'impact du programme
- ne pas oublier de s'intéresser aux soignants => amélioration des pratiques par exemple
- ne pas oublier d'utiliser les ressources à disposition